

两位北京医生的线上意见

一 分析与解读

日期：2026年8月29日 给：雨杰

依据：好大夫线上问诊截图 — 李萃萃（解放军总医院第七医学中心）两条回复、孙振兴（北京清华长庚医院）一条回复。

结论先说：两位医生的意见**并不矛盾**，一致的地方比不同的地方多；唯一真正的分歧（脂肪瘤切多少）是这个领域几十年没有定论的老问题，不代表谁对谁错。**现在的排序不变：李萃萃第一，孙振兴作为第三意见。**面诊时用第八部分的五个问题，谁能"看着你的片子"回答，就选谁。

一、两位医生到底说了什么

李萃萃 副主任医师（第七医学中心）

第一条回复：建议做脊髓拴系松解手术，手术目的是**阻止或延缓病情进展**。松解后再针对大小便问题做骶神经调控术。一般住院15—20天，术后观察两到三个月看二便功能恢复情况，再根据病情考虑是否做骶神经调控术。

第二条回复（你问"大概能移除多少脂肪瘤？术后还会长大吗？"）：**重点是脊髓拴系松解，成年人多数不再长了，详细的面诊再说。**

孙振兴 副主任医师（清华长庚）

你已经出现明显的大小便功能障碍。对于脂肪瘤型脊髓拴系，**首次手术依然推荐脂肪瘤大部切除 + 拴系松解 + 终丝切断术**。术后如果大小便功能恢复不佳，二期可以做骶神经电刺激。每周五上午到清华长庚神经外科门诊面诊，可以加号，会尽早安排治疗。

二、一致的地方（这是最重要的信号）

- 现在就**该手术**，不是观察等待。
- 松解拴系是手术的核心**。
- 手术的目标是**"止住"**，不是**"治好"** — 阻止或延缓进展。两位都没有承诺大小便功能一定能恢复。
- 骶神经调控（骶神经电刺激）是计划中的第二步** — 如果术后大小便恢复不理想，再做。
- 两位都建议**面诊**，线上回复只是初步意见。

这个共识与李医生团队2024年发表的论文立场一致，也与国际文献一致。两位专科医生独立得出同样的判断，说明诊断和大方向是清楚的。

三、唯一的分歧：脂肪瘤切多少

这是脊髓脂肪瘤手术领域**最老、至今没有定论**的问题。世界上有两派：

	彻底切除派 (美国 Pang 教授学派)	保守松解派
做法	尽量把脂肪瘤全部或近全部切除，重建脊髓	以松解为主，只切能干净分离的部分
长期再拴系率	约 3—4%	10—20年后约 20—50%
手术当下风险	较高，需要专门团队和术中神经电生理监测	较低，新增神经损伤的机会较小
前提	脂肪瘤与脊髓的界面能分得开	—

孙医生的**"大部切除"**是教科书式的中间立场 — 切大部分，不是全切。

李医生的**"重点是松解"**听起来偏保守。但是请注意：她那句话是在**推迟回答，不是手术方案**。她只看过线上传的资料，还没有仔细研究你的影像，所以她说"详细的面诊再说"。孙医生的回复则是一句通用的标准推荐（"依然推荐"），也不是针对你片子的方案。

两位现在都还没有给出针对你具体解剖的手术计划。

四、为什么你的情况本身就偏向谨慎

MRI 报告写得很清楚：

- 脂肪瘤**延伸至左侧神经孔，包绕左侧 L5 神经根**；
- 左侧 S1 神经根神经节受压；
- 脂肪瘤最大径 121 毫米，位于马尾。

在神经根被包绕的地方做激进切除，正是新的神经损伤最容易发生的地方。

一位经验丰富的脂肪瘤外科医生看到"121毫米马尾脂肪瘤、神经根被包绕、成年、进行性加重"，很可能会想：**在监测下松解，能干净分开的部分切掉，不要在 L5 神经根周围去追着脂肪切**。而经验较少的医生会背诵标准方案。

这与我们之前对三位医生的调查结论一致：**李萃萃** — 脊髓拴系是她的主业，师从修波教授，151条拴系专项评价；**孙振兴** — 好大夫上没有任何脊髓拴系相关的评价，在科室里是副组长，拴系只是他工作中排在中间的一项。

五、注意"积极程度"的差别

孙医生主动提出加号、"尽早安排治疗"；李医生给的是住院天数和一个冷静的时间表。

积极不等于水平高。如果说有什么区别，病例量较少的医生反而更希望接收病人。不要因为谁回复更热情就改变排序。

六、"成年人多数不再长了" — 正确，但有一个和你有关的注意事项

脊髓脂肪瘤不是肿瘤，它随身体脂肪一起变化。**体重快速增加 — 包括怀孕 — 可能使它变大**。这正好印证了我们之前在生育文件里定的顺序：**先松解手术，再考虑怀孕**。

七、日程上的一个小问题

- 孙振兴：**周五上午**，清华长庚（昌平天通苑，北京很北边）
- 李萃萃：**周五下午**，第七医学中心（东城区东四十条）
- 崔志强：周四上午，玉泉医院

9月11日（周五）一天看两位在物理上可行（两地约一小时车程），但很紧。无论如何先看李萃萃。

八、面诊时决定一切的五个问题（两位都问同样的问题）

- 按您的分型，我这是哪一种脂肪瘤**（背侧型 / 过渡型 / 尾侧型 / 混乱型）？**对于被包绕的左侧 L5 神经根，您的具体方案是什么？**
- 您计划切除多少，为什么？**用这种方法，您做的成人脂肪瘤病例**5年以上的再拴系率**是多少？
- 术中神经电生理监测：**有没有神经根定位、触发肌电图、球海绵体反射 / 肛门括约肌监测？是不是每台手术都常规做？
- 皮样窦道**（S1处有强化的那个）：**是否在同一次手术中完整切除整条窦道？**（这一点没有商量余地。）
- 硬膜重建：**如果不做彻底切除，您用什么方法降低再拴系风险 — 扩大硬膜成形？术后脊髓与硬膜囊的比例？

能根据你的片子回答这些问题、而不是背诵标准流程的那位医生，就是该选的医生。

九、结论

- 两份线上意见**没有改变排序：李萃萃第一，孙振兴第三意见**。
- 两位都确认：现在手术、松解为核心、目标是止住进展、骶神经调控作为第二步。这是好消息 — 方向是清楚的。
- 切多少脂肪瘤，要等有人真正看过你的影像后再定。面诊就是为了这个。
- 带上 MRI 光盘（DICOM）、英文报告和中文翻译、尿动力学报告，以及这份文件里的五个问题。

本文件是根据线上问诊截图和已有病历所做的整理分析，供你理解和准备面诊使用；最终诊疗方案以面诊医生的判断为准。